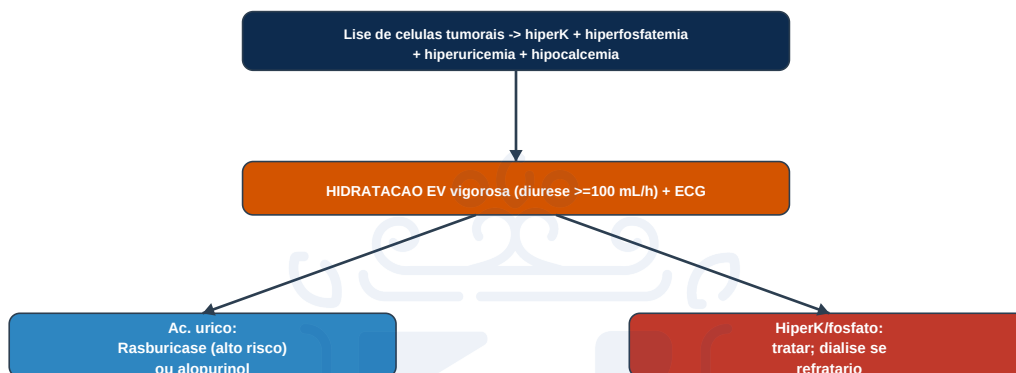


SÍNDROME DE LISE TUMORAL

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA METABÓLICA

LISE TUMORAL — HIDRATAR, BAIXAR ÁCIDO ÚRICO, K



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Emergência oncológica e metabólica por destruição maciça de células tumorais (espontânea ou induzida por tratamento)
- Liberação abrupta de conteúdo intracelular: HIPERURICEMIA, HIPERCALEMIA, HIPERFOSFATEMIA, HIPOCALCEMIA secundária
- Alto risco: leucemias agudas, linfoma de Burkitt, linfomas de alto grau, alta carga tumoral, neoplasias muito quimiossensíveis
- Pode ser assintomática no início — a vigilância LABORATORIAL é fundamental

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

POR SISTEMA

- Neurológicas: letargia, confusão, convulsões (hipocalcemia)
- Cardiovasculares: arritmias, parada cardíaca (HIPERCALEMIA)
- Renais: oligúria, anúria, edema (nefropatia por ácido úrico/fosfato)
- Gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia
- ECG é OBRIGATÓRIO (avaliar hipercalemia/hipocalcemia)

EXAMES E DIAGNÓSTICO

CAIRO-BISHOP (laboratorial + clínico)

- Iniciais: hemograma, ureia/creatinina, ÁCIDO ÚRICO, potássio, FÓSFORO, cálcio, gasometria
- ECG obrigatório
- Lise laboratorial: alterações de ≥ 2 (ácido úrico, K, fósforo, cálcio) em torno do início do tratamento
- Lise clínica: lise laboratorial + IRA, arritmia ou convulsão
- Avaliar volemia e débito urinário

TRATAMENTO — HIDRATAÇÃO E ÁCIDO ÚRICO

Rx BASE DO TRATAMENTO

HIDRATAÇÃO EV: SF 0,9% 200-300 mL/h, meta de diurese ≥ 100 mL/h (cautela em IC/IRA)
Hiperuricemia (alto risco/SLT estabelecida): RASBURICASE 0,15-0,2 mg/kg EV dose única (ação em horas)
CONTRAINDICADA na deficiência de G6PD (risco de hemólise/metemoglobinemia)
Profilaxia / casos leves: Alopurinol 300 mg VO/dia (não reduz o ácido úrico JÁ formado)
Não usar alcalinização urinária de rotina (favorece precipitação de fosfato de cálcio)

TRATAMENTO — DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS

Rx K, FÓSFORO, CÁLCIO

HIPERCALEMIA ($K \geq 6,0$ ou alteração no ECG): Gluconato de cálcio 10% 10 mL EV em 10 min + Insulina 10 UI EV + glicose 25 g + furosemida se euvolêmico/hipervolêmico
HIPERFOSFATEMIA: restrição de fósforo + quelante (Sevelamer 800-1600 mg VO 8/8h)
HIPOCALCEMIA: NÃO corrigir se assintomática (risco de precipitação de fosfato de cálcio); corrigir só se convulsão/arritmia/tetania (gluconato de cálcio)
Monitorização cardíaca contínua; eletrólitos seriados
DIÁLISE: hipercalemia refratária, acidose grave, sobrecarga volêmica, IRA progressiva, hiperfosfatemia grave sintomática

RED FLAGS / ENCAMINHAMENTO

TODOS DEVEM SER ENCAMINHADOS

- Todo paciente com síndrome de lise tumoral deve ser internado/encaminhado a serviço especializado
- Necessidade de exames seriados, nefrologia e, frequentemente, leito de UTI
- Hipercalemia é a causa de morte mais temida (arritmia/PCR)
- Não corrigir hipocalcemia assintomática (piora a precipitação de fosfato de cálcio renal)
- Antecipar a profilaxia em pacientes de alto risco antes da QT

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com SLT (neoplasia ____; última QT há ____); ácido úrico ____, K ____, fósforo ____, cálcio ____, creatinina ____.
- ECG: ____; débito urinário ____; sintomas: ____ (arritmia/convulsão/oligúria).
- Condutas: hidratação ____ mL/h, rasburicase/alopurinol, manejo de hiperK; diálise: sim/não.
- Solicito internação + nefrologia + leito de UTI (exames seriados).

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a base do tratamento da síndrome de lise tumoral?

- A) Restrição hídrica
- B) Hidratação endovenosa vigorosa (meta de diurese ≥ 100 mL/h)
- C) Bicarbonato de rotina
- D) Diálise para todos imediatamente
- E) Reposição de cálcio em todos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual distúrbio eletrolítico da síndrome de lise tumoral é a principal causa de morte (arritmia/PCR)?

- A) Hipocalcemia
- B) Hipercalemia
- C) Hiperfosfatemia
- D) Hiponatremia
- E) Hipomagnesemia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Em qual situação a rasburicase é CONTRAINDICADA?

- A) Insuficiência renal
- B) Deficiência de G6PD
- C) Hipercalemia
- D) Idade avançada
- E) Linfoma de Burkitt

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a hipocalcemia na síndrome de lise tumoral, é correto:

- A) Deve ser sempre corrigida com cálcio EV
- B) Não corrigir se assintomática (corrigir só se convulsão, arritmia ou tetania) pelo risco de precipitação de fosfato de cálcio
- C) Indica diálise imediata
- D) É sinal de bom prognóstico
- E) Contraindica a hidratação

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quais neoplasias são de ALTO risco para síndrome de lise tumoral?

- A) Tumores sólidos pequenos
- B) Leucemias agudas, linfoma de Burkitt e linfomas de alto grau (alta carga tumoral/quimiossensíveis)
- C) Carcinoma basocelular
- D) Tumores benignos
- E) Cistos ovarianos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A base do tratamento é a hidratação EV vigorosa (SF 0,9% 200-300 mL/h) com meta de diurese ≥ 100 mL/h, para proteger o rim da precipitação de ácido úrico/fosfato, associada ao controle do ácido úrico e dos eletrólitos.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hipercalcemia é o distúrbio mais perigoso (arritmias e parada cardíaca) na síndrome de lise tumoral — exige ECG, monitorização e tratamento imediato (cálcio, insulina+glicose, etc.).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A rasburicase é contraindicada na deficiência de G6PD pelo risco de hemólise grave e metemoglobinemia (o peróxido de hidrogênio gerado pela uricase não é detoxificado).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipocalcemia da SLT não deve ser corrigida se assintomática, pois repor cálcio com fósforo elevado favorece a precipitação de fosfato de cálcio (lesão renal). Corrige-se só se convulsão, arritmia ou tetania.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Alto risco: leucemias agudas, linfoma de Burkitt e linfomas de alto grau, além de tumores de alta carga e muito quimiossensíveis — nesses, antecipa-se a profilaxia (hidratação $\pm$ rasburicase/alopurinol).

SM24
Suporte ao Plantão Médico